

Trastorno Bipolar I y II – Episodios maníacos, hipomaníacos y depresivos, estabilizadores del ánimo

1. Introducción y relevancia clínica

El **trastorno bipolar (TB)** es una enfermedad mental crónica y recurrente caracterizada por **fluctuaciones patológicas del ánimo**, que alternan entre **episodios depresivos, maníacos o hipomaníacos**, intercalados con periodos de eutimia.

Afecta aproximadamente al **1-3% de la población mundial**, con inicio típico entre los **15 y 30 años**, y una **alta carga de discapacidad** si no se trata adecuadamente.

En Chile, es una **patología GES (Garantía Explícita en Salud)** desde 2013, asegurando tratamiento continuo en el sistema público.

El TB es clínicamente relevante porque:

- Se asocia a **alto riesgo suicida (hasta 20%)**.
- Genera **impacto social y laboral significativo**.
- Es frecuentemente **mal diagnosticado como depresión mayor**, lo que conduce a tratamientos inadecuados (por ejemplo, uso de ISRS sin estabilizador, que puede inducir manía).

□ En el **EUNACOM**, las preguntas suelen enfocarse en:

- Diferenciar episodio depresivo bipolar vs. unipolar.
- Diagnosticar episodio maníaco o hipomaníaco.
- Seleccionar el estabilizador del ánimo apropiado (litio, valproato, lamotrigina).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La fisiopatología del TB es compleja y multifactorial. Combina **alteraciones neurobiológicas, genéticas y ambientales**.

2.1. Neurobiología

- **Deregulación dopaminérgica y serotoninérgica:**

Aumento de dopamina durante manía y disminución durante depresión.

- **Anomalías en la neurotransmisión glutamatérgica:**

Exceso de excitabilidad neuronal en manía.

- **Alteración del eje HHA (hipotálamo–hipófisis–adrenal):**

Similar a la depresión, con hipercortisolemia sostenida.

- **Disminución del BDNF:**

Reducción de la neuroplasticidad y del volumen hipocampal.

2.2. Genética

- Alta heredabilidad: hasta **70–80%**.
- Riesgo de 10–15% si un progenitor afectado; 60% si ambos lo están.

2.3. Factores precipitantes

- Estrés psicosocial.
- Privación de sueño.
- Sustancias estimulantes (cocaína, anfetaminas).
- Uso de antidepresivos sin estabilizador.
- Alteraciones endocrinas (tiroides, posparto).

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Trastorno Bipolar tipo I

Presencia de **al menos un episodio maníaco** (con o sin episodios depresivos).

Episodio maníaco – criterios DSM-5:

- **Ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable**, durante ≥ 1 semana (o cualquier duración si hospitalizado).
- ≥ 3 (≥ 4 si el ánimo es solo irritable) de los siguientes:
 1. Autoestima exagerada o grandiosidad.
 2. Disminución de la necesidad de dormir (< 3 h sin cansancio).
 3. Verborrea o presión del habla.
 4. Fuga de ideas o pensamiento acelerado.
 5. Distractibilidad.
 6. Aumento de actividad dirigida a metas o agitación psicomotora.
 7. Implicación excesiva en actividades de riesgo (gastos, sexualidad, inversiones).

Requiere:

- Deterioro funcional marcado o hospitalización.
- No atribuible a sustancias o causas médicas.

3.2. Trastorno Bipolar tipo II

Requiere **≥ 1 episodio hipomaniaco + ≥ 1 episodio depresivo mayor.**

No hay manía completa.

Episodio hipomaniaco:

- Misma sintomatología que manía, pero **duración ≥ 4 días**, sin compromiso funcional grave ni hospitalización.

Característica	Manía (TB I)	Hipomanía (TB II)
Duración	≥ 1 semana	≥ 4 días

Gravedad	Grave, con deterioro funcional o psicótico	Leve a moderado
Hospitalización	Frecuente	No necesaria
Asociación	Puede alternar con depresión o eutimia	Siempre alterna con depresión

3.3. Episodio depresivo bipolar

Indistinguible clínicamente de la depresión unipolar, pero con algunas **pistas orientadoras**:

Indicador de bipolaridad	Descripción
Inicio precoz (<25 años)	Curso más fluctuante
Historia familiar de TB	Frecuente
Episodios breves y recurrentes	Duran semanas o pocos meses
Hipersomnia e hiperfagia	Comunes
Malas respuestas a ISRS	O viraje maníaco
Irritabilidad y labilidad afectiva	Más que tristeza pura

❑ El error más frecuente en APS y en EUNACOM es **diagnosticar depresión unipolar y tratar con ISRS sin estabilizador**, lo cual **puede inducir manía o ciclación rápida**.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Exámenes básicos (antes de tratamiento)

Examen	Finalidad
Hemograma, electrolitos, perfil hepático y renal	Uso seguro de estabilizadores
TSH	Descartar hipotiroidismo o efectos del litio
β-hCG	Evitar teratogenicidad (valproato, carbamazepina)
EKG	Si uso de litio o antipsicóticos
Glicemia y lípidos	Control metabólico (antipsicóticos atípicos)

4.2. Instrumentos clínicos

- **Escala de Young (YMRS):** cuantifica severidad de manía.
 - **Escala de Hamilton o PHQ-9:** para depresión bipolar.
-

4.3. Diagnóstico

Es **clínico**, basado en historia detallada, antecedentes familiares y evolución temporal.

Debe documentarse el tipo (I o II), presencia de síntomas psicóticos y número de episodios.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile 2023–2024)

El manejo del TB debe ser **integral, continuo y multidisciplinario**, combinando **farmacoterapia, psicoeducación y psicoterapia**.

5.1. Fase aguda maníaca

Objetivo:

controlar la excitación psicomotora y estabilizar el ánimo.

Primera línea:

1. **Litio** 600–1800 mg/día (niveles plasmáticos 0.6–1.2 mEq/L).
 - Eficaz para manía clásica, pero requiere monitoreo renal y tiroideo.
2. **Valproato de sodio** 750–1500 mg/día.
 - Útil en manía mixta o ciclación rápida.
3. **Antipsicóticos atípicos** (risperidona, quetiapina, olanzapina).
 - Control rápido de agitación y psicosis.

Segunda línea: carbamazepina, haloperidol.

- ☐ En cuadros severos con agitación, puede iniciarse **combinación litio + antipsicótico atípico**.
-

5.2. Fase depresiva bipolar

No usar antidepresivos en monoterapia.

Primera línea:

- **Lamotrigina** (titulación lenta, útil en prevención de depresión).
- **Litio** (eficaz en depresión bipolar leve a moderada).
- **Quetiapina o lurasidona** (efectivas según evidencia actual).

Segunda línea:

- **Combinación litio + ISRS (sertralina o fluoxetina)** solo con estrecho monitoreo.

- **Evitar venlafaxina o tricíclicos** (alto riesgo de viraje).
-

5.3. Mantenimiento

- **Litio:** estándar oro para prevenir recaídas.
- **Valproato:** alternativa útil si intolerancia o ciclación rápida.
- **Lamotrigina:** previene depresión más que manía.
- **Psicoeducación:** mejora adherencia y reduce recaídas (evidencia robusta).
- **Terapia cognitivo-conductual o interpersonal:** apoyo complementario.

Duración del tratamiento:

- Primer episodio: ≥ 2 años.
 - Recurrente o grave: indefinido.
-

5.4. Manejo en APS y derivación

- Control y ajuste inicial de ISRS o estabilizadores simples.
 - Derivar a psiquiatría si:
 - Episodio maníaco o mixto.
 - Riesgo suicida.
 - Psicosis o mala adherencia.
 - Falta de respuesta al tratamiento de primera línea.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones

- Suicidio (riesgo 20–30 veces mayor que población general).
- Abuso de sustancias.
- Ciclación rápida (>4 episodios/año).
- Deterioro cognitivo progresivo.
- Efectos adversos de estabilizadores (nefrotoxicidad, hipotiroidismo, hepatotoxicidad).

Pronóstico

- Sin tratamiento: curso crónico y deterioro funcional.
- Con manejo adecuado: 60–70% logra buena estabilidad.
- Mejor pronóstico: adherencia, psicoeducación familiar y seguimiento regular.
- Peor pronóstico: inicio precoz, comorbilidad ansiosa o abuso de sustancias.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Diferencia clave:** TB I = manía; TB II = hipomanía + depresión.
2. **Nunca usar ISRS solos** en depresión bipolar.
3. **Litio** es el estabilizador más eficaz y reduce **riesgo suicida**.
4. **Valproato** preferido en ciclación rápida o manía mixta.
5. **Lamotrigina** útil para prevención de episodios depresivos.
6. **Antipsicóticos atípicos** controlan manía y síntomas psicóticos.
7. **Monitorear** función renal y tiroidea (litio) y hepática (valproato).
8. **Evitar privación de sueño**, ya que puede precipitar recaída.



Errores comunes

- Tratar depresión bipolar con ISRS sin estabilizador.
- No reconocer episodio hipomaniaco previo.
- No monitorear litemia ni efectos adversos.
- Suspender estabilizador tras remisión inicial.
- Usar antidepresivos tricíclicos (riesgo de manía severa).

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **trastorno bipolar** se caracteriza por alternancia de episodios maníacos/hipomaniacos y depresivos.
2. El **tipo I** incluye manía; el **tipo II** presenta hipomanía + depresión.
3. El tratamiento base son los **estabilizadores del ánimo: litio, valproato, lamotrigina**.
4. Los **ISRS nunca deben usarse en monoterapia** (riesgo de viraje).
5. **Psicoeducación y adherencia** son claves para prevenir recaídas.
6. **Litio** disminuye el riesgo de suicidio, pero requiere control renal y tiroideo.
7. Con tratamiento adecuado, el paciente puede mantener **funcionalidad y remisión prolongada**.